

«Гіпертонічна хвороба»

1. Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- Виміряти артеріальний тиск за методом Короткова.
- Описати ЕКГ.
- Оцінити [добове моніторування артеріального тиску](#).
- Встановити попередній діагноз.
- Визначити тактику ведення та лікування пацієнта.
- Означити рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя.

2. Клінічні кейси (сценарії, задачі), які відпрацьовуються на станції з пакетами додаткових матеріалів:

- Сценарій «Діагностика та подальша тактика ведення і лікування хворого з діагнозом гіпертонічна хвороба».

Ви лікар поліклініки. До Вас звернувся чоловік 65 років, водій рейсового автобуса.

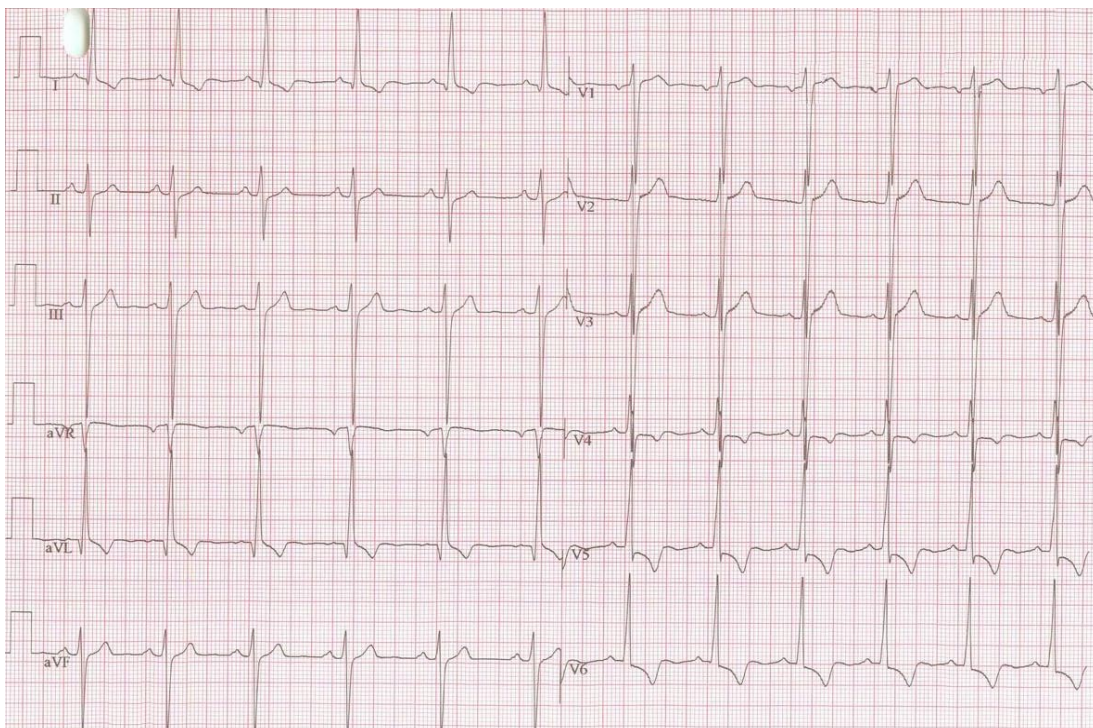
Скарги на головний біль, запаморочення, біль за грудиною.

Анамнез захворювання: хворіє на гіпертонічну хворобу біля 2 років. Протягом 2 місяців регулярно приймає вранці телмісартан 40 мг та гідрохлортіазід 12,5 мг. Незважаючи на прийом ліків головний біль продовжує турбувати, у зв'язку з чим звернувся до лікаря.

Анамнез життя: Шкідливі звички: палив 20 років пачку/день, 2 роки тому кинув. Спадковість – мати хворіла на гіпертонічну хворобу, померла від інсульта.

Об'єктивно. Стан відносно задовільний. Шкіра блідо-рожева, чиста. Набряків немає. У легенях – везикулярне дихання. Межі відносної серцевої тупості збільшені ліворуч на 2,5 см. Тони серця приглушені ритмічні, акцент 2 тону на аорті. ЧСС=Пульс=82 за хв. Живіт м'який безболісний. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

Додаток 1. ЕКГ



Додаток 2.Добове моніторування артеріального тиску

ДОБОВЕ МОНІТОРУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ	
Вимірювання проведено на апаратіВТЛна тлі прийому терапії:телмісартан 40 мг і гідрохлортіазид 12,5 мг вранці, з кількістю вимірювань 34.	
Основні результати	
Середньодобовий АТ: 148/98 mmHg	
Середньоденний АТ: 156/101.8mmHg	
Середньонічний АТ: 125.5/719.1mmHg	
Перевищення допустимої норми АТ	
Зареєстровано навантаження гіпертонічними величинами:	
Індекс часу САТ вдень: 85% - стійко підвищений (N↓ 25%)	
Індекс часу ДАТ вдень: 79%- стійко підвищений (N↓ 25%)	
Індекс часу САТ вночі: 52% - стійко підвищений (N↓ 25%)	
Індекс часу ДАТ вночі: 43% - стійко підвищений (N↓ 25%)	
Добовий індекс 16 % - добовий профіль "dipper".	
Варіабельність САТ – 18 % ((N↓ 15%)	
Варіабельність САТ – 14 % ((N↓ 12%)	
Висновок	
За даними добового моніторування АТ зареєстровано стійке підвищення САТ і ДАТ вдень за адекватним зниженням вночі, профіль "dipper".	

3. Інформація для студента – алгоритм роботи на станції:

Ви зібрали скарги, анамнез захворювання та життя, провели об'єктивне обстеження.

Алгоритм дій здобувача.

	<i>Дії здобувача освіти</i>
1.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):	
	інформовану згоду отримано; руки та мембрану фонендоскопу оброблено на гігієнічному рівні.
2.ВИКОНАННЯ НАВИЧКИ «ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ МЕТОДОМ КОРОТКОВА»	
	Коректно (на рівні серця) розташувати руки пацієнта та перевірити манометр
	Коректне (на оголене плече, нижній край манжети розташувати на 2-3 см вище за ліктьовий згин) накладання манжети
	Коректно (центр ліктьової ямки) розташувати акустичну голівку фонендоскопа
	Накачати повітря у манжетку
	При стравлюванні повітря з манжетки зафіксувати рівень систолічного (поява першого тону Короткова) та діастолічного (зникнення тонів Короткова) артеріального тиску
	Зняття манжети
	Самопочуття пацієнта задовільне
3. ДІАГНОСТИКА:	
<i>Описати ЕКГ</i> (Додаток 1)	Ритм синусовий. Правильний. Електрична вісь серця відхилена ліворуч. ЧСС – 65 за хвилину. Гіпертрофія міокарда лівого шлуночка з систолічним перевантаженням
<i>Оцінити добове моніторування артеріального тиску</i> (Додаток 2)	Упацієнта на тлі прийому телмісартану 40 мг і гідрохлортіазиду 12,5 мг вранці відзначається недостатнє зниження систолічного і діастолічного артеріального тиску
<i>Встановити попередній діагноз:</i>	Гіпертонічна хвороба II ст. 2 ст. ризик високий

4.ВИЗНАЧЕННЯ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ	
<i>Призначено наступні ліки:</i>	Телмісартан 40 мг Гідрохлортіазид 12,5 мг Лерканідіпін 10 мг або група антагоністів кальцію (дігідропірідинові похідні) Проведення домашнього моніторингу артеріального тиску Ведення щоденника для запису результатів домашнього моніторингу АТ
5. Профілактика та пропаганда здорового способу життя:	
	Залучати пацієнта до участі в програмах немедикаментозної корекції факторів ризику: школи здоров'я, програми відмови від тютюнокуріння, програми психологічної підтримки та реабілітації
	Навчання пацієнта: щодо особливостей перебігу захворювання, необхідності чіткого дотримання призначеного лікування, щодо потенційних побічних дій призначених препаратів та можливих взаємодій лікарських засобів.